

Tiamina *ratuje pamięć*

Niedobór witaminy B1 u osoby pijącej może w ciągu dni zniszczyć pamięć trwale. Profilaktyka jest tania, leczenie wczesne — odwracalne. Ten arkusz wyjaśnia, na co zwracać uwagę.

CZAS: 12 min Psychoedukacja powikłania

ŹRÓDŁO: Harper i wsp. (1986); Thomson i wsp. (2008); Sechi & Serra (2007)

JAK UŻYWAĆ

Zapoznaj się z **triadą Wernickego** (sekcja 01) — trzema objawami, których pojawienie się u osoby pijącej wymaga *pilnej* pomocy medycznej. Sekcja 02 wyjaśnia, czym różni się *Wernicke* (odwracalny) od *Korsakowa* (zwykle nieodwracalnego). Sekcja 03 — codzienna profilaktyka. Skonsultuj z lekarzem, czy **codzienna tiamina (witamina B1)** jest dla Ciebie wskazana.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Alkohol blokuje wchłanianie i metabolizm tiaminy (witamina B1). U osoby pijącej ciężko niedobór rozwija się w tygodniach. *Encefalopatia Wernickego* bez leczenia w 80% przypadków przechodzi w zespół *Korsakowa* — przewlekłą, najczęściej **nieodwracalną** amnezję. Pełna triada objawów jest obecna tylko u **~16%** chorych (Harper, 1986) — większość przypadków nie zostaje rozpoznana. Tiamina w iniekcji kosztuje grosze, ratuje pamięć trwale. To *jedno z najbardziej zapobiegalnych poważnych powikłań w medycynie*.

01 ✕ Triada Wernickego — trzy objawy alarmowe

U osoby pijącej, jeśli pojawi się którykolwiek z poniższych objawów (nawet jeden, nie wszystkie trzy) — to *pilne wezwanie pomocy medycznej*. Nie czekaj, aż pojawi się pełna triada — to za późno na pełne odwrócenie zmian.

1 · SPLĄTANIE

dezorientacja w czasie i miejscu

Nie wie, jaki jest dzień, gdzie jest, kim są bliscy. Zachowuje się „nie jak on/ona”. Często mylone z odstawieniem albo nietrzeźwością, ale **utrzymuje się bez alkoholu**.

2 · ATAKSJA

zaburzenia równowagi i chodu

Chód na szerokiej podstawie, niepewny, jak w stanie nietrzeźwym — **również wtedy, gdy nie pił**. Trudność w stanięciu z zamkniętymi oczami. Powtarzające się upadki.

3 · ZABURZENIA OKORUCHOWE

oczopląs, podwójne widzenie

Oczopląs (mimowolne ruchy gałek ocznych), podwójne widzenie, opadanie powieki, niemożność pełnego ruszenia okiem w bok lub w górę.

Częsta pułapka medyczna: u osoby z niedoborem tiaminy *podanie glukozy bez wcześniejszej tiaminy* może **wyzwolić** pełnobjawową encefalopatię. Każdy hospitalizowany pacjent z AUD — najpierw tiamina (i.v./i.m.), potem ewentualnie glukoza.

02 ? Wernicke vs Korsakow — różnica, która decyduje

WERNICKE — ETAP OSTRY

Triada objawów (splątanie + ataksja + zaburzenia okoruchowe). Pojawia się **w ciągu dni**.

Odwracalny przy szybkim podaniu wysokich dawek tiaminy. Im wcześniej leczone — tym mniej trwałych następstw.

→ *okno terapeutyczne — godziny i dni*

KORSAKOW — ETAP PRZEWLEKŁY

Głęboka amnezja anterogradna (nie zapamiętuje nowych rzeczy), *konfabulacje* (mózg automatycznie „wypełnia” luki spójnymi historiami — to nie kłamstwo). Pacjent przytomny, rozmawia, ale nie pamięta, co powiedział 5 minut wcześniej.

→ *nieodwracalny — wymaga opieki długoterminowej*

Konfabulacje bywają mylone z manipulacją lub kłamstwem. To **nie jest świadome działanie** — mózg pacjenta z zespołem Korsakowa automatycznie tworzy spójną narrację, by zapełnić deficyt pamięci. Pacjent *wierzy* w te opowieści. Stąd kluczowa rola rodziny i opiekunów w prowadzeniu pacjenta z Korsakowem.

03 ✓ Codzienna profilaktyka — co możesz zrobić sam/-a

SUPLEMENTACJA TIAMINY

Skonsultuj z lekarzem codzienne przyjmowanie **tiaminy 100 mg doustnie**. Dostępna bez recepty (np. *Vitaminum B1*). Kosztuje grosze, bezpieczna, dobrze tolerowana.

ODŻYWIANIE

Mięso, ryby, jaja, pełnoziarniste produkty, rośliny strączkowe. *Tiamina jest w nich naturalnie*. Osoby pijące często niedojadają — w jadłospisie tych grup typowo brakuje.

INFORMOWANIE LEKARZY

Powiedz każdemu nowemu lekarzowi (POZ, SOR, anestezjolog) o piciu. Standardowo dostaniesz tiaminę **przed** ewentualną kroplówką z glukozą.

PLAN NA DETOKS

Jeśli planujesz odstawienie alkoholu — zacznij **tydzień wcześniej** przyjmować tiaminę 100 mg/d. To buduje zapasy przed momentem największej wrażliwości mózgu.

04 ✎ Mój plan

CO SKONSULTUJĘ Z LEKARZEM PRZY NAJBLIŻSZEJ WIZYCIE

— *tiamina, badania krwi, plan odstawienia*

KOGO Z BLISKICH POINFORMUJĘ O TRIADZIE WERNICKEGO

— *żeby wiedzieli, kiedy pilnie szukać pomocy*

Klucz: Zespół Wernickego-Korsakowa to *najbardziej zapobiegalne* trwałe uszkodzenie mózgu w medycynie. Tiamina **500 mg dożylnie**, podana w pierwszych godzinach od pojawienia się triady, w większości przypadków cofa objawy. *Sechi & Serra (2007, Lancet Neurology)*: „opóźnienie podania tiaminy nawet o 24 godziny istotnie zwiększa ryzyko przejścia w nieodwracalny Korsakow.” Dlatego trzymaj ten arkusz lub zdjęcie pod ręką — i pokaż go każdemu lekarzowi, do którego trafisz.